

■ DOLORCONCIENCIA · BIOLOGÍA DEL DOLOR

Protocolo 28 Días

Espalda y Cuello

El método con aval científico que en 15 minutos al día
cambia cómo tu cuerpo procesa el dolor —
diseñado para cualquier profesión

FASE 1
SOLTAR

FASE 2
FORTALECER

FASE 3
INTEGRAR

59 páginas

43 ilustraciones

Perfil de dolor personalizado

Para cualquier profesión

Desde casa · Sin aparatos

Bienvenida

Antes de empezar — leé esto

Si llegaste hasta acá, probablemente ya sabés exactamente de qué estoy hablando.

Ese pinchazo en el sacro que aparece de repente. Los nudos en la espalda alta que no cierran. La cintura baja que se agarrota después de horas intensas frente a la pantalla. El cuerpo que cobra, siempre, en los días más exigentes.

Yo lo viví. Soy bióloga. Estudié años, trabajé intensamente frente a una pantalla, y en algún momento mi cuerpo empezó a guardar toda esa tensión. El médico me dijo lo mismo que probablemente te dijeron a vos: "No tenés nada roto. Es postural." Tenía razón. Y al mismo tiempo, no era suficiente respuesta.

Así que empecé a investigar — con la mentalidad de bióloga, revisando la evidencia científica real de lo que funciona para el dolor musculoesquelético crónico. Y lo apliqué en mí misma.

Hoy trabajo más de 8 horas frente a la computadora. Y no vuelvo a padecerlo.

Este protocolo de 28 días es exactamente lo que uso. Está organizado en 3 fases que van desde soltar la tensión acumulada, hasta fortalecer para que no vuelva, hasta integrarlo como tu nueva normalidad.

15 minutos por día. Sin equipamiento. Desde donde estés.

Bienvenida.

— María José · Bióloga · DolorConCiencia

■ Señales de alarma — Leé esto antes de empezar

Este programa es seguro para la gran mayoría de las personas con dolor crónico de espalda y cuello. Sin embargo, hay síntomas que requieren atención médica antes de hacer cualquier ejercicio.

■ PARÁ Y CONSULTÁ URGENTE SI TENÉS:

- Dolor que baja al brazo o pierna **con hormigueo o entumecimiento severo**
- **Pérdida de fuerza** en la mano, el pie o la pierna
- Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio repentina
- **Incontinencia urinaria o fecal** de aparición reciente
- Dolor que **no cede en ninguna posición** — ni acostada, ni de pie
- Dolor **nocturno intenso que te despierta**, sin relación con el movimiento
- Fiebre + dolor de espalda al mismo tiempo
- **Antecedente de cáncer** y dolor de espalda nuevo o que empeora
- Traumatismo reciente (caída, accidente) antes del inicio del dolor

■ CONSULTÁ ANTES DE EMPEZAR SI TENÉS:

- Hernia discal **con síntomas activos** (dolor irradiado, hormigueo leve)
- Estenosis espinal diagnosticada
- Osteoporosis severa
- Cirugía de columna en los últimos **6 meses**
- Embarazo (especialmente 2° y 3° trimestre)
- Dolor agudo de menos de **3 semanas de evolución** con mucha limitación funcional
- Diagnóstico de espondilitis anquilosante u otra enfermedad inflamatoria articular
- Dolor que empeoró significativamente en las últimas **72 horas**

■ Este programa ES para vos si:

- Tenés dolor de espalda o cuello de más de 3 meses de duración (crónico)
- Tu médico o fisioterapeuta ya descartó causas graves
- Tu dolor está relacionado con la postura, el sedentarismo o el estrés
- Podés moverte con molestia pero sin dolor invalidante
- Querés aprender a manejar tu dolor con evidencia científica, no con pastillas

Si tenés dudas sobre si este programa es para vos, mostráselo a tu médico o fisioterapeuta. El contenido está basado en protocolos clínicos validados y es seguro para la gran mayoría de personas con dolor crónico inespecífico.

Tu perfil de dolor — antes de empezar

Respondé estas preguntas honestamente. No hay respuestas correctas ni incorrectas — el objetivo es que el programa funcione mejor para vos. Marcá la opción que más se acerque a tu situación actual.

PREGUNTA 1

¿Dónde sentís el dolor con más frecuencia?

Solo en la espalda baja (lumbar)	Solo en el cuello y/o hombros	En la espalda baja Y en el cuello	En la espalda media (entre omóplatos)	En múltiples zonas
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------

PREGUNTA 2

¿Hace cuánto tenés este dolor?

3 a 6 meses	6 meses a 1 año	1 a 3 años	Más de 3 años	Va y viene desde hace mucho tiempo
-------------	-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

PREGUNTA 3

¿Qué empeora tu dolor?

Estar sentada mucho tiempo	Estar de pie mucho tiempo	Dormir o levantarme	El estrés o la ansiedad	El movimiento o el ejercicio	Varias de las anteriores
-------------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

PREGUNTA 4

¿Tu dolor irradia hacia algún lado?

No, se queda en el mismo lugar	A veces baja hacia la cola o el muslo	A veces sube hacia la cabeza o baja al brazo	Baja hasta la pantorrilla o el pie	Siento hormigueo o entumecimiento
-----------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------------------------------------

PREGUNTA 5

¿Cuánto afecta el dolor tu vida diaria?

Poco — puedo hacer todo con algo de molestia	Moderado — evito algunas actividades	Bastante — cambié muchos hábitos por el dolor	Mucho — el dolor limita casi todo lo que hago
---	---	--	--

PREGUNTA 6

¿Hacés algún tipo de ejercicio actualmente?

No, casi nada	Camino o algo suave a veces	Hago ejercicio 1-2 veces por semana	Hago ejercicio más de 3 veces por semana
---------------	-----------------------------	--	---

PREGUNTA 7

¿Cómo describirías tu trabajo o tu día típico?

Trabajo en escritorio/computadora (sedentario)	Trabajo de pie o caminando mucho	Trabajo físico (carga, movimiento constante)	Mezcla de todo	Actualmente no trabajo o soy ama de casa
--	----------------------------------	--	----------------	--

PREGUNTA 8

¿Qué esperas de este programa?

Eliminar el dolor completamente	Reducir el dolor a un nivel manejable	Entender por qué tengo dolor	Aprender a prevenir que vuelva	Todo lo anterior
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------

¿Qué dicen tus respuestas?

Según tus respuestas, identificá el perfil que más se acerca a tu situación. Podés tener características de más de uno — eso es completamente normal.

■ Perfil A — Dolor lumbar postural (el más frecuente)

Si tu dolor está principalmente en la espalda baja, empeora al estar sentada mucho tiempo, y mejora con el movimiento, este es tu perfil. La causa más común es la debilidad del core profundo combinada con flexores de cadera tensos. **Prestá especial atención a la Fase 1 (días 1-5) y a los ejercicios de transverso y puente de cadera en la Fase 2.**

■ Perfil B — Dolor cervical y de hombros (trabajo en pantalla)

Si tu dolor está en el cuello, los hombros o entre los omóplatos, y empeora al usar la computadora o el teléfono, este es tu perfil. La causa más común es la debilidad de los flexores cervicales profundos y la disfunción escapular. **Los días 2 y 4 de la Fase 1, y los días 10-11 de la Fase 2 son críticos para vos.**

■ Perfil C — Dolor mixto lumbo-cervical

Si el dolor aparece en múltiples zonas, va y viene, y parece relacionado con el estrés o la tensión general, este es tu perfil. Suele involucrar sensibilización central. **La sección de neurociencia del dolor en la introducción es especialmente importante para vos. No te saltes los ejercicios de respiración — son tan importantes como los de fuerza.**

■ Perfil D — Dolor con irradiación

Si el dolor baja hacia la pierna o sube hacia el brazo, este perfil tiene una carga discogénica o nerviosa mayor. **Empezá la Fase 1 con mucha calma. Si algún ejercicio aumenta el dolor irradiado (no el dolor local), detené el ejercicio y consultá a un profesional.** La extensión McKenzie del Día 22 puede ser especialmente útil si el dolor se centraliza.

■ Antes de empezar el Día 1 — tu línea de base

Anotá en tu cuaderno o en el espacio de abajo:

Mi dolor hoy (0-10): ____	0 = sin dolor · 10 = el peor dolor imaginable
Fecha de inicio: ____ / ____ / ____	Lo vas a necesitar para comparar al final
Mi perfil principal: ____	A (lumbar) · B (cervical) · C (mixto) · D (irradiacion)

La Base

Semanas 1 - Días 1 a 7

Empezamos donde todo comienza: el sistema nervioso. Antes de fortalecer, necesitamos que el cerebro aprenda a moverse sin miedo. Esta semana vas a reprogramar los patrones de movimiento basicos y activar los músculos que protegen tu columna.

En esta fase:

- Día 1 — El reset
- Día 2 — Desactivar la alarma
- Día 3 — La base
- Día 4 — El cinturón
- Día 5 — Las raíces
- Día 6 — Tu primer flujo
- Día 7 — Mirá lo que construiste

1

La Reconstruccion

Semanas 2 y 3 - Días 8 a 21

Ya tenes la base. Ahora construimos encima. Esta fase introduce fuerza real, progresion de carga y patrones de movimiento funcionales. Tu columna va a empezar a sentirse como un ancla, no como un punto debil.

En esta fase:

- Día 8 — Encender el motor
- Día 9 — El puente
- Día 10 — Hombros en casa
- Día 11 — El detective
- Día 12 — La potencia
- Día 13 — Tu primer flujo fuerte
- Día 14 — La mitad del camino
- Día 15 — Fuerza avanzada
- Día 16 — Cadena posterior completa
- Día 17 — El circuito del core
- Día 18 — Integración funcional
- Día 19 — Fuerza sostenida
- Día 20 — Flujo semana 3
- Día 21 · Evaluación Fase 2

2

La Libertad

Semana 4 - Días 22 a 28

La ultima semana no es el final — es el comienzo de tu nueva normalidad. Integramos todo lo aprendido en movimientos complejos y te damos las herramientas para mantener estos resultados de por vida.

En esta fase:

- Día 22 — Moverse sin miedo
- Día 23 — Resistencia real
- Día 24 — Mente y movimiento
- Día 25 — El cuerpo en el mundo
- Día 26 — Tu rutina para siempre
- Día 27 — El flujo final
- Día 28 — La libertad

3

DIA 1

El reset

Respiración, movimiento y presencia - 15 minutos

■ El dolor crónico involucra sensibilización central: el sistema nervioso aprende a enviar señales de alarma incluso sin daño real. La respiración diafragmática activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo esa sensibilización.

EJERCICIOS

01 Respiración diafragmática

1. Acostáte boca arriba, rodillas dobladas, pies apoyados.
2. Poné una mano en el pecho, otra en el abdomen.
3. Inhalá 4 segundos: el abdomen sube, el pecho casi no se mueve.
4. Exhalá 6 segundos: el abdomen baja lentamente.
5. 10 ciclos. No fuerces — dejá que el cuerpo encuentre el ritmo.



■ Activa el nervio vago, modulando la respuesta al dolor a nivel del tronco cerebral.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si el abdomen no sube, poné un libro liviano sobre la panza — el peso da feedback táctil inmediato. Este patrón puede tardar 3-5 días en normalizarse: es el reflejo de respiración compensatoria revertiendo. Paciencia.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si la posición acostada genera dolor, hacélo sentada con la espalda bien apoyada. El beneficio neurológico es exactamente el mismo.

02 Escaneo corporal

1. Seguí acostada. Cerrá los ojos.
2. Llevá la atención a los pies — notá sensaciones sin juzgarlas.
3. Subí lentamente: tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, cadera, abdomen, pecho, hombros, cuello, cabeza.
4. No tratés de cambiar nada. Solo observar.
5. 3–4 minutos de recorrido.



■ *Entrena la interocepción. Las personas con dolor crónico tienen interocepción reducida — esta práctica la reactiva progresivamente.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** Que la mente "viaje" es completamente normal. No estás tratando de relajarte — estás aprendiendo a observar sin reaccionar. En dolor crónico, este ejercicio reactiva la corteza insular que procesa señales corporales con más precisión.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si 3-4 minutos es demasiado, empezá con 90 segundos. La calidad de atención importa más que el tiempo.

03 Rotación suave de cuello

1. Sentáte derecho en una silla, hombros relajados.
2. Girá la cabeza suavemente hacia la derecha hasta donde llegues sin dolor.
3. Volvé al centro. Girá hacia la izquierda.
4. 5 veces por lado. Muy lento.
5. Notá si hay diferencia entre un lado y el otro.



■ *Activa mecanorreceptores del cuello que compiten con señales de dolor a nivel medular (teoría de la compuerta).*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** El objetivo NO es llegar lejos — es moverse despacio y sin dolor. Si un lado tiene menos rango, no lo fuerces: el sistema nervioso está protegiendo esa zona. Con repetición diaria, el rango mejora solo.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si sentís mareo, hacélo acostada mirando el techo con los ojos fijos en un punto. Eso ayuda al sistema vestibular a adaptarse.

04 Apertura de pecho

1. De pie o sentada, brazos abiertos a los lados en T.
2. Pecho expandido hacia adelante, hombros hacia atrás y abajo.
3. Respirá profundo mientras mantenés la posición.
4. 5 repeticiones de 10 segundos.



■ *Contrarresta la postura cifótica del trabajo en pantalla, activando los retractores escapulares.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si los hombros suben hacia las orejas al abrir los brazos, bajálos conscientemente primero. Respirá hondo antes de abrir — eso ayuda a que las costillas participen del movimiento.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Hacélo sentada, apoyando los codos en el respaldo de la silla y expandiendo el pecho hacia adelante.

05 Inclinación pélvica

1. Acostáte boca arriba, rodillas dobladas.
2. Inhalá. Al exhalar, aplastá la zona lumbar contra el suelo.
3. Inhalá y volvé a la posición neutra.
4. Pequeño movimiento, muy controlado. 10 repeticiones.



■ *Reactiva la propiocepción lumbo-pélvica, primer paso para recuperar el control motor de la columna.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Poné una mano bajo la zona lumbar — deberías sentir cómo el espacio entre tu espalda y el suelo cambia. Pequeño rango = correcto. No es un movimiento grande ni visible.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si hay dolor lumbar agudo, hacélo sentada en silla con las mismas instrucciones. El movimiento es más pequeño pero igualmente efectivo.

■ Hábito del día: ¿Podés apoyar la espalda completamente en el respaldo? ¿La pantalla está a la altura de los ojos? Dos ajustes simples pueden reducir la carga cervical hasta un 40%.

DIA 2

Desactivar la alarma

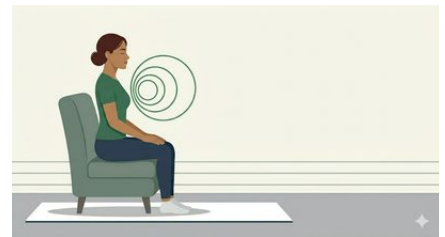
Cuello y hombros libres - 15 minutos

■ El esternocleidomastoideo y escalenos son los músculos más tensos en quienes trabajan frente a pantalla. Desactivarlos reduce directamente la cefalea tensional y el dolor cervical.

EJERCICIOS

01 Respiración 4-4-6

1. Inhalá por la nariz durante 4 segundos.
2. Retené el aire 4 segundos.
3. Exhalá lentamente por la boca durante 6 segundos.
4. 8 ciclos. Hacélo antes de sentarte a trabajar.



■ La retención activa el sistema nervioso autónomo hacia el modo parasimpático, reduciendo la sensibilización central.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si la retención genera ansiedad al principio, empezá sin ella: 4 inhala, 6 exhala solamente. Incorporá la retención gradualmente en la semana 2 cuando el patrón se normalice.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: ¿Te cuesta contar? Usá una app de respiración (Breathwrk, Calm) para los primeros días.

02 Inclínación lateral de cuello

1. Sentáte derecho. Dejá caer suavemente la oreja derecha hacia el hombro.
2. No levantes el hombro — que sea la cabeza la que se mueve.
3. Mantené 20 segundos. Sentís el estiramiento en el lado izquierdo.
4. Volvé. Repetí hacia el izquierdo. 2 por lado.



■ *Descomprime los escalenos sin activar el reflejo de estiramiento brusco que genera más tensión.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: El error más frecuente es que el hombro sube compensando el rango. Usá un espejo los primeros días, o apoyáте contra la pared — si el hombro toca la pared, está subiendo.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si sentís pinchazón, reducí el rango a la mitad. No necesitás llegar al hombro — la zona de estiramiento suave es suficiente y segura.

03 Chin tuck — Retracción cervical

1. Sentáte derecho. Imaginá un hilo tirando de la coronilla hacia el techo.
2. Deslizá la cabeza hacia atrás — como haciendo doble papada.
3. No inclines la cabeza — es un deslizamiento horizontal.
4. 5 segundos. 10 repeticiones.



■ *Activa los flexores profundos del cuello (longus colli), inhibidos en cervicalgia crónica. Su reactivación reduce el dolor en 6-8 semanas.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

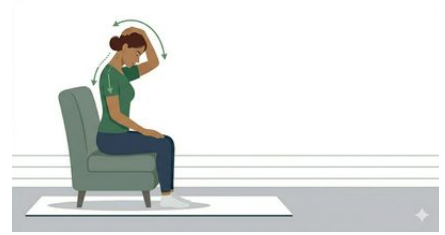
■ Tip: La clave es "cabeza hacia atrás en el espacio", NO "mentón hacia abajo". La diferencia es sutil pero cambia qué músculos trabajan. Hacélo apoyada contra la pared para guiar el movimiento horizontal.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si no sentís el movimiento correcto de pie, hacélo acostada boca arriba: apretá levemente la nuca contra el suelo. Ese es exactamente el músculo que buscás activar.

04 Estiramiento de trapecio

1. Sentáte derecho. Inclíná la cabeza hacia la derecha.
2. Además, girá levemente el mentón hacia la clavícula.
3. La mano derecha sobre la cabeza, aplica presión suave.
4. El hombro izquierdo permanece abajo. 30 segundos. 2 por lado.



■ *El trapecio superior es el músculo más sobrecargado en el trabajo sedentario — este estiramiento lo descomprime sin generar más tensión.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: La diferencia con la inclinación lateral es la rotación del mentón hacia la clavícula — ese pequeño giro cambia el ángulo y focaliza el estiramiento en el trapecio profundo.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si la presión de la mano genera incomodidad en el cuello, hacélo sin la mano, solo con el peso de la cabeza inclinada.

05 Retracción escapular

1. Sentada o de pie, codos doblados a 90°.
2. Llevá los codos hacia atrás juntando los omóplatos.
3. No levantes los hombros — el movimiento es horizontal.
4. Mantené 5 segundos. 12 repeticiones.



■ *Activa trapecio medio e inferior — los músculos más débiles en quienes trabajan con los brazos hacia adelante.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Imaginá que querés "apretar un lápiz entre los omóplatos". Al final del movimiento, los hombros deben estar levemente más bajos que al empezar, nunca más altos.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Hacélo con una banda elástica liviana para agregar resistencia cuando las repeticiones sin carga sean fáciles.

■ Hábito del día: El monitor ideal tiene la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos. Mirar el celular con la cabeza a 45° genera 22 kg de presión sobre las vértebras cervicales — levánta el teléfono a la altura de los ojos.

DIA 3

La base

La columna lumbar - 15 minutos

■ La lumbalgia crónica involucra pérdida del control motor lumbo-pélvico. Estos ejercicios re-educan el movimiento desde el patrón más básico, sin generar carga compresiva.

EJERCICIOS

01 Gato — Vaca (Cat-Cow)

1. En cuadrupedia (manos y rodillas). Columna neutral.
2. GATO: Exhalá arqueando la espalda hacia el techo, cabeza abajo.
3. VACA: Inhalá hundiendo la espalda, cabeza y cola arriba.
4. Alternálos lentamente. 10 ciclos. Muy fluido.



■ *Moviliza cada segmento de la columna y lubrica los discos intervertebrales mediante el movimiento del fluido sinovial.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Dividí el movimiento en 2 fases: columna torácica primero, luego lumbar. Muchas personas solo mueven la lumbar — perdiendo la mitad del beneficio. Intentá que cada vértebra participe secuencialmente.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si las rodillas duelen, poné una toalla doblada debajo. Si las muñecas duelen, hacélo sobre los puños cerrados o apoyada en antebrazos.

02 Postura del niño

1. Desde cuadrupedia, llevá los glúteos hacia los talones.
2. Extendé los brazos hacia adelante, frente cerca del suelo.
3. Respirá profundo — cada exhalo te alarga un poco más.
4. 5 respiraciones profundas. Sin forzar.



■ *Descomprime la columna lumbar por tracción longitudinal suave y estira el cuadrado lumbar bilateralmente.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** Si los glúteos no llegan a los talones, poné un almohadón entre pantorrillas e isquiones. El objetivo es la sensación de alargamiento en la espalda, no la posición perfecta.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si hay dolor en rodillas o caderas, sentáte en el borde de una silla e inclinéte hacia adelante con los brazos sobre los muslos.

03 Puente básico

1. Acostáte boca arriba, rodillas dobladas, pies a ancho de cadera.
2. Exhalá y activá levemente el abdomen.
3. Elevá la cadera formando una línea recta hombro-rodilla.
4. Mantené 5 segundos. Bajá lento. 10 repeticiones.



■ *Activa glúteo mayor e isquiotibiales, reduciendo la carga en la columna lumbar al fortalecer la cadena posterior.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** La secuencia correcta: primero activá el abdomen (leve tensión), luego levantá los glúteos. Si los isquiotibiales calambran, poné los pies un poco más lejos del cuerpo antes de subir.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si no podés llegar a la posición completa, subí solo hasta donde no haya dolor. Incluso 5 cm de elevación ya activa los glúteos correctamente.

04 Rotación lumbar en supino

1. Acostáte boca arriba, rodillas juntas dobladas.
2. Brazos en T, hombros pegados al suelo.
3. Dejá caer las rodillas hacia la derecha. Cabeza al lado contrario.
4. 30 segundos. Vuelve al centro. Repetí al otro lado.



■ *Moviliza las facetas articulares lumbares y estira el cuadrado lumbar, psoas e ilíaco contralateral.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Los hombros permanecen en contacto con el suelo durante todo el movimiento — eso es más importante que llegar lejos con las rodillas. Si un lado tiene menos rango, ese cuadrado lumbar o cadera está más tenso.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si hay dolor al rotar, reducí el rango. Las rodillas solo bajan hasta donde no duela — aunque sea apenas unos centímetros.

■ Hábito del día: Cada 45 minutos sentada, levántate 2 minutos. Activá los glúteos de pie antes de volver a sentarte — ese micro-hábito reduce la presión discal acumulada en un 30%.

DIA 4

El cinturón

Control cervical y postura - 15 minutos

■ La debilidad de los estabilizadores cervicales profundos y escapulares es la causa principal del dolor crónico de cuello en personas con trabajo sedentario. Hoy los entrenamos.

EJERCICIOS

01 Chin tuck con resistencia

1. Sentáte derecho. Poné 2 dedos en la barbilla.
2. Empujá suavemente la barbilla hacia atrás contra los dedos.
3. Los dedos resisten — la cabeza no se mueve (isométrico).
4. 5 segundos de contracción. 10 repeticiones.



■ *El trabajo isométrico con resistencia activa los flexores profundos (longus colli) de forma selectiva, sin activar el esternocleidomastoideo superficial.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: La resistencia debe ser muy suave — 2 dedos, no la palma entera. Si sentís tensión en la PARTE DE ATRÁS del cuello, es porque estás usando extensores en lugar de flexores. Reducí la resistencia.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Hacélo apoyada contra la pared — el contacto con la pared te guía el plano de movimiento y elimina las compensaciones.

02 Wall angel

1. Apoyáte contra la pared: cabeza, hombros, codos y muñecas en contacto.
2. Brazos en "W" (codos a 90°, a la altura de los hombros).
3. Desliza los brazos hacia arriba hasta la "Y", sin perder contacto.
4. Vuelve lentamente. 10 repeticiones.



■ *Entrena la rotación superior de la escápula y activa el serrato anterior y el trapecio inferior — los más débiles en el trabajo de escritorio.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** Los 4 puntos de contacto (cabeza, hombros, codos, muñecas) son el estándar. Si alguno no llega, no lo fuerces — trabajá en tu rango disponible. Con el tiempo, llegar a todos ellos mejora naturalmente.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si la espalda baja se despega de la pared, poné los pies 5 cm más alejados — eso inclina la pelvis y ayuda al contacto lumbar.

03 Apertura de pecho con toalla

1. Sostené una toalla o banda con ambas manos, más anchas que los hombros.
2. Brazos extendidos al frente a la altura del pecho.
3. Abre los brazos hacia los lados estirando la toalla.
4. Pecho expandido. 15 repeticiones. Lento y controlado.



■ *Entrena la retracción escapular con carga liviana y aumenta el rango de extensión torácica.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** El movimiento debe ser controlado y lento. Si los hombros se encorvan al abrir la toalla, reducí el rango. El objetivo es entrenar la retracción escapular, no el rango máximo de apertura.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Sin toalla: cruza los brazos al frente y abre los codos hacia los lados. El movimiento es más pequeño pero activa los mismos músculos.

■ **Hábito del día:** Programá una alarma cada 45 minutos. Cuando suene: 3 respiraciones diafragmáticas + chin tuck × 5. Son 60 segundos que re-programan tu postura a lo largo del día.

DIA 5

Las raíces

Caderas y pelvis - 15 minutos

■ Los flexores de cadera tensos y los glúteos inhibidos son la combinación más común en el dolor lumbar crónico. Hoy trabajás las dos estructuras que más influyen en la posición de tu columna.

EJERCICIOS

01 Estiramiento del flexor de cadera

1. Posición de estocada baja: rodilla derecha en el suelo.
2. Pie izquierdo adelante con rodilla a 90°.
3. Torso erguido, cadera delantera empujada suavemente hacia adelante.
4. 30 segundos por lado. 2 repeticiones.



■ *El psoas tenso (por estar sentada mucho tiempo) aumenta la lordosis lumbar y la compresión discal. Este estiramiento lo libera directamente.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: La sensación correcta es en la parte **FRONTAL** de la cadera **TRASERA**, no en la rodilla que está abajo. Activá el glúteo de la pierna trasera — eso intensifica el estiramiento del psoas significativamente.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si no podés arrodillarte, hacélo de pie apoyada contra la pared: llevá una rodilla hacia el pecho mientras extendés la cadera contraria.

02 Estiramiento del piriforme — Figura 4

1. Acostáte boca arriba. Cruzá el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda.
2. Con ambas manos, jalá el muslo izquierdo hacia el pecho.
3. Sentís el estiramiento en el glúteo derecho.
4. 30 segundos. Cambiá. 2 por lado.



■ El piriforme tenso comprime el nervio ciático. Este estiramiento libera esa tensión sin cargar la columna.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: La clave es el "jalón activo": el brazo tira del muslo hacia el pecho mientras el pie está en el suelo. Si el estiramiento es muy intenso en la zona sacra (no en el glúteo), bajá el ángulo de cruce.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si no llegás a los muslos con las manos, poné una correa o toalla alrededor del muslo para jalar desde ahí.

03 Estiramiento del cuadrado lumbar

1. De pie, pies firmes separados al ancho de cadera.
2. Llevá el brazo derecho sobre la cabeza.
3. Incliná el torso hacia la izquierda, estirando el costado derecho.
4. 30 segundos. Cambiá. 2 por lado.



■ El cuadrado lumbar es uno de los músculos más implicados en el dolor lumbar crónico — este estiramiento alivia su tensión acumulada.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Los pies permanecen fijos y la mano que sube va en línea con la oreja, no adelante. Si los pies se mueven, perdés el estiramiento del cuadrado lumbar.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Hacélo sentada en una silla si estar de pie genera inestabilidad. El efecto sobre el cuadrado lumbar es muy similar.

■ Hábito del día: Si trabajás sentada más de 4 horas, poné una alarma para levantarte y caminar 3 minutos cada hora. Los flexores de cadera se acortan a los 20 minutos de sedestación sostenida.

DÍA 6

Tu primer flujo

Conectar los movimientos en una secuencia - 15 minutos

■ Los ejercicios no son nuevos — la diferencia es que los encadenás sin pausa larga. La secuencia entrena el sistema nervioso para que los patrones de movimiento fluyan automáticamente.

EJERCICIOS

01 Calentamiento: Respiración + Escaneo

1. 5 respiraciones diafragmáticas lentas.
2. Escaneo rápido de 2 minutos de cabeza a pies.
3. Notá qué cambió respecto al Día 1.

■ *El sistema nervioso necesita este encendido antes del flujo — sin él, los músculos responden más lento.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Prestá atención a las diferencias con el Día 1. Esas diferencias son datos reales de tu progreso — el sistema nervioso ya empezó a cambiar.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si estás cansada o con poco tiempo, hacé solo este calentamiento. 7 minutos de consciencia corporal siempre son mejor que nada.

02 Secuencia lumbar — suelo

1. Inclínación pélvica: 8 repeticiones lentas.
2. Rodillas al pecho: 30 segundos meciéndote suavemente.
3. Gato-Vaca: 8 ciclos siguiendo la respiración.
4. Puente de cadera: 8 repeticiones, 5 segundos arriba.

■ *Encadenar estos ejercicios sin pausa larga entrena la co-activación secuencial de los estabilizadores lumbares.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** No apures el ritmo entre ejercicios. La transición entre movimientos es parte del entrenamiento — el sistema nervioso está aprendiendo a conectar los patrones.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si algún ejercicio todavía genera incomodidad, hazlo en su versión modificada del día correspondiente.

03 Secuencia cervical y hombros — silla

1. Chin tuck: 10 repeticiones.
2. Inclínación lateral de cuello: 2 por lado, 20 segundos.
3. Rotación de hombros: 8 hacia atrás, 8 hacia adelante.
4. Apertura de pecho: 3 veces, 20 segundos.
5. Cierre: Respiración 4-4-6, 5 ciclos con ojos cerrados.

■ *Al terminar, tomáte 30 segundos para notar cómo está el cuerpo. Eso entrena la conciencia corporal — parte del tratamiento del dolor crónico.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** Los 30 segundos finales de escaneo consolidan el aprendizaje motor de toda la sesión. No los omitás — son los más valiosos.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si hay fatiga cervical, reducí las repeticiones a la mitad. La calidad importa más que la cantidad.

■ **Hábito del día:** Hidratación — los discos intervertebrales son 80% agua. 8 vasos al día no es un cliché, es fisiología básica. Los discos bien hidratados absorben mejor la carga.

DÍA 7

Mirá lo que construiste

Una semana de presencia cambia más que años de ignorar - 15 minutos

■ Una semana de ejercicio consciente diario produce cambios medibles en la sensibilización central. El sistema nervioso ya comenzó a re-aprender que el movimiento es seguro.

EJERCICIOS

01 Reflexión y registro

- ¿En qué días sentiste más alivio después de los ejercicios?
- ¿Qué ejercicio fue el más difícil? ¿Por qué?
- ¿Notaste algún patrón en tu dolor (hora, postura, actividad)?
- ¿Qué parte del cuerpo siente más diferente respecto al Día 1?

■ *La reflexión sobre el proceso activa la corteza prefrontal, que modula la respuesta al dolor. Escribir las respuestas triplica el efecto.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si el dolor no mejoró significativamente, es normal en la semana 1. Los cambios en sensibilización central tardan 3-4 semanas. Lo importante es la consistencia, no la velocidad.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si no pudiste hacer todos los días, identificá qué lo impidió. Ese obstáculo es el que hay que resolver para la Fase 2.

02 Test de rango y secuencia de cierre

1. Rotación de cuello — ¿Llegás al hombro? Anotá.
2. Chin tuck — ¿10 reps sin compensar? Anotá.
3. Puente de cadera — ¿10 reps fluidas? Anotá.
4. Realizá la secuencia completa del Día 6.
5. Cierre: escaneo corporal de 3 minutos.

■ *Comparar el Día 7 con el Día 1 activa el sistema de recompensa, reforzando el hábito del ejercicio diario.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: No te compares con nadie más que con vos misma del Día 1. Cualquier mejora, por pequeña que sea, es evidencia de que el sistema nervioso está cambiando.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si estás cansada, hacé solo el escaneo corporal y la respiración. Un día de recuperación activa es parte del programa.

■ ¡Completaste la Fase 1! 7 días de presencia. 7 días de movimiento consciente. En la Fase 2 empezás a reconstruir la fuerza que sostiene todo lo demás.

DIA 8

Encender el motor

El core real - 20 minutos

■ El "core" no es el six-pack — es el sistema de presión abdominal que estabiliza la columna en todos los movimientos. El transverso abdominal, el diafragma y el suelo pélvico forman este sistema.

EJERCICIOS

01 Dead Bug — Bicho muerto

1. Acostáte boca arriba. Brazos verticales hacia el techo, rodillas a 90° en el aire.
2. Exhalá completamente (activa el core).
3. Extendé el brazo derecho hacia atrás y la pierna izquierda hacia adelante simultáneamente.
4. Volvé. Cambiá de lado. 8 repeticiones por lado.



■ Entrena la estabilización anti-rotación del core, el patrón más importante para proteger la columna en actividades cotidianas.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: La espalda baja NUNCA debe despegarse del suelo — eso indica que el core está activo. Antes de extender, exhalá completamente: eso pre-activa el transverso. Empezá extendiendo solo las piernas, sin mover los brazos.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si la espalda se despegas, reducí el rango de extensión a 45°. El control importa más que el rango completo.

02 Perro-Pájaro — Bird Dog

1. En cuadrupedia, columna neutral (ni arqueada ni redondeada).
2. Extendé el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás.
3. Mantenélos en línea con el torso. Caderas niveladas.
4. 5 segundos. Volvé. Cambiá. 10 por lado.



■ Activa los extensores espinales multifidos junto con el glúteo mayor, entrenando la co-contracción que estabiliza la lumbar.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Las caderas deben permanecer niveladas — no rotar. Poné un vaso de agua en la espalda baja: si cae, la cadera rotó. La extensión debe ser gradual y controlada, nunca un lanzamiento.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Empezá moviendo solo la pierna, sin el brazo. Cuando ese control sea estable (3-4 días), agregá el brazo.

■ Hábito del día: El core se activa en TODAS las actividades. Al levantarte de la silla, activá levemente el abdomen antes de empujar — eso reduce la presión discal en cada transferencia.

DIA 9

El puente

Glúteos y lumbar - 20 minutos

■ El glúteo mayor es el músculo más grande del cuerpo y el principal estabilizador de la pelvis. Su debilidad (glute amnesia) es una causa directa del dolor lumbar crónico.

EJERCICIOS

01 Clamshell — Almeja

1. Acostáte de lado, caderas y rodillas dobladas a 45°.
2. Mantené los pies juntos. Abrió la rodilla de arriba como una almeja.
3. La pelvis NO rota — el movimiento viene de la cadera.
4. 15 repeticiones. Cambiá lado.



■ *Activa el glúteo medio — el más débil en personas con dolor lumbar y el más importante para la estabilidad lateral de la pelvis.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

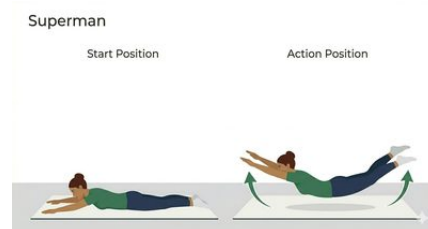
■ Tip: Si la pelvis rota al abrir la rodilla, estás usando el cuadrado lumbar en lugar del glúteo medio. Reducí el rango hasta que solo se mueva la cadera. Este control es más valioso que el rango.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Cuando las repeticiones sin resistencia sean fáciles, agregá una banda elástica liviana justo encima de las rodillas.

02 Superman

1. Acostáte boca abajo, brazos extendidos al frente.
2. Levantá simultáneamente brazos y piernas del suelo.
3. La extensión de la columna es suave, no máxima.
4. 3 segundos. Bajá lento. 10 repeticiones.



■ Activa los extensores espinales (multífidos y erector espinal) bilateralmente, fortaleciendo la cadena posterior.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: El error más común es extender la cabeza hacia atrás al subir — eso comprime las cervicales. Mantené la mirada hacia el suelo durante todo el movimiento.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Empezá levantando solo los brazos (sin piernas) durante 3 días. Luego solo piernas. Combiná cuando tengas control de cada parte.

■ Hábito del día: "Squeeze and release" glúteos al estar de pie esperando (colectivo, cocina, ascensor). 10 contracciones de 3 segundos contrarrestan horas de glute amnesia sentada.

DIA 10

Hombros en casa

Escápulas y manguito rotador - 20 minutos

■ El 70% del dolor cervical crónico tiene componente de disfunción escapular. Las escápulas son la base del movimiento del brazo — si no se mueven bien, el cuello compensa todo.

EJERCICIOS

01 Wall Slides

1. Apoyáte contra la pared, brazos en W (codos a 90°, pegados a la pared).
2. Desliza los brazos hacia arriba manteniendo contacto con la pared.
3. Vuelve lentamente. 10 repeticiones.

Wall Slides



■ Entrena la rotación superior escapular y activa el serrato anterior, corrigiendo la disquinesia escapular que genera impingement de hombro.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si los codos o muñecas no llegan a la pared, no los fuerces — trabajá en el rango disponible. El serrato y trapecio inferior se activan solo si mantenés los puntos de contacto SIN compensar con el cuello.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Sentada con los brazos sobre una mesa, imitá el mismo deslizamiento hacia adelante — activa los mismos músculos con menos carga.

02 Rotación externa de hombro

1. De pie o sentada. El codo derecho pegado al costado, doblado a 90°.
2. Rotá la mano hacia afuera, alejándola del abdomen.
3. Vuelve lentamente. El codo NO se mueve del costado.
4. 15 repeticiones. Cambiá lado.

Rotación Externa de Hombro



■ Activa el *infraespinoso* y *redondo menor* del manguito rotador — los estabilizadores dinámicos del hombro más frecuentemente débiles.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: El codo PERMANECE pegado al costado — si se despega, el movimiento lo realiza el deltoides en lugar del manguito. Poné una toalla doblada entre el codo y la costilla como recordatorio táctil.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si hay dolor en el hombro, hacélo en el rango indoloro únicamente. No es necesario llegar a 90° para obtener el beneficio sobre el manguito.

■ Hábito del día: Los hombros "redondeados" hacia adelante se generan por el acortamiento del pectoral menor. Hacer la apertura de pecho del Día 1 antes de sentarte a trabajar contrarresta ese patrón.

DIA 11

El detective

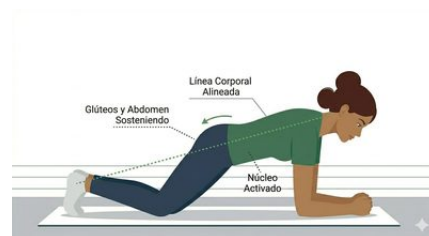
Patrones funcionales del core - 20 minutos

■ La plancha no es un ejercicio de resistencia — es un ejercicio de control motor. El objetivo no es cuánto tiempo aguantás, sino la calidad de activación en cada segundo.

EJERCICIOS

01 Plancha en rodillas

1. Apoyáte en antebrazos y rodillas. Columna recta.
2. Activá el abdomen y apretá los glúteos.
3. El cuerpo forma una línea diagonal desde cabeza hasta rodillas.
4. Mantené 20-30 segundos. 3 series.



■ Entrena la co-contracción de transverso, multifidos y glúteos — el "corsé natural" de la columna lumbar.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: La línea recta desde cabeza hasta rodillas es más importante que el tiempo. Si los glúteos suben o el abdomen cae, reducí el tiempo a la mitad. 15 segundos perfectos > 60 segundos mal ejecutados.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si hay dolor en las muñecas, hacélo sobre antebrazos (plancha de codos). El beneficio de core es exactamente el mismo.

■ Hábito del día: Activá el core al cargar cosas. Antes de levantar cualquier peso (bolsas, mochila, bebé), exhalá y activá el abdomen. Ese micro-hábito protege la lumbar en los movimientos de carga.

DIA 12

La potencia

Cadena posterior - 20 minutos

■ La bisagra de cadera (hip hinge) es el movimiento más importante para la salud de la columna. Es la base del peso muerto, el levantamiento seguro y la prevención de lesiones lumbares.

EJERCICIOS

01 Bisagra de cadera — Hip Hinge

1. De pie, pies al ancho de cadera.
2. Con espalda RECTA (no redondeada), empujá las caderas hacia atrás.
3. El torso se inclina hacia adelante manteniendo la curvatura lumbar.
4. Volvé empujando las caderas hacia adelante. 12 repeticiones.



■ Activa los isquiotibiales y glúteo mayor en cadena posterior, enseñando el patrón de carga seguro para la columna.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Empezá de pie a 30 cm de la pared y tocéla con los glúteos al inclinarte — eso enseña el movimiento de "empujar caderas hacia atrás". Una bisagra de 30° con espalda recta es MEJOR que una de 90° con espalda redondeada.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si no podés mantener la espalda recta, reducí el rango de inclinación. Usá un palo de escoba apoyado en la espalda para sentir cuándo la columna se redondea.

02 Sentadilla asistida

1. De pie frente a una silla o puerta, sosteniéndola con las manos.
2. Pies al ancho de hombros, puntas hacia afuera 15-30°.
3. Dobla rodillas siguiendo la dirección de los pies, caderas atrás.
4. Hasta paralelo o donde llegues sin dolor. 12 repeticiones.

Sentadilla Asistida



■ Entrena el patrón de sentadilla con carga reducida, activando cuádriceps, glúteos e isquiotibiales en cadena cerrada.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Las rodillas siguen la dirección de los pies — ni hacia adentro (valgo) ni hacia afuera. Mirá tus rodillas durante el movimiento. La silla/puerta guía el movimiento, no sostiene el peso.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Empezá sentándote y levantándote de una silla alta. Cuando eso sea fácil (sin usar los brazos), probá con una silla más baja.

■ Hábito del día: Cada vez que levantes algo del suelo, usá la bisagra de cadera que aprendiste hoy. Doblar desde las rodillas con espalda recta reduce la presión discal lumbar en un 60% comparado con doblar desde la cintura.

DIA 13

Tu primer flujo fuerte

Todo lo que aprendiste, junto - 20 minutos

■ El flujo encadena todos los patrones de movimiento aprendidos. El objetivo no es sumar repeticiones — es observar cómo los movimientos ya se sienten más automáticos que en el Día 8.

EJERCICIOS

01 Calentamiento — 4 minutos

1. Respiración diafragmática: 5 ciclos.
2. Activación del transverso: 10 x 8 segundos.
3. Inclinación pélvica: 10 repeticiones.
4. Gato-Vaca: 8 ciclos.

■ *El calentamiento activa el sistema nervioso central antes de la carga. Saltárselo reduce la calidad de todos los ejercicios siguientes.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: La activación del transverso es sutil: es como "meter el abdomen" suavemente sin contener la respiración. Ese músculo es el más importante del core profundo.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si tenés poco tiempo, hacé solo el calentamiento y el cierre. 7 minutos de calidad mantienen el progreso.

02 Bloque de suelo — 8 minutos

1. Dead Bug completo: 8 por lado.
2. Superman modificado: 8 repeticiones.
3. Clamshell lateral: 12 por lado.
4. Puente con tempo 3-5-3: 10 repeticiones.
5. Plancha en rodillas: 3 x 20 segundos.

■ 20-30 segundos de descanso entre ejercicios es suficiente. La calidad siempre primero — el cansancio no justifica perder la forma.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si algún ejercicio todavía no se siente automático, no pasa nada. La automatización completa llega entre la semana 3 y 4. Seguí enfocada en la calidad.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si la plancha de rodillas todavía es difícil, reducí a 10 segundos pero hacé las 3 series. La consistencia importa más que la duración.

03 Bloque de pie — 5 minutos

1. Wall Slides: 10 repeticiones.
2. Sentadilla asistida: 10 repeticiones.
3. Bisagra de cadera: 10 repeticiones.
4. Equilibrio en un pie: 20 segundos x 2 por lado.

■ El trabajo de pie activa la cadena cinética completa · los músculos trabajan coordinados como en la vida real.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: En el equilibrio en un pie, los ojos fijos en un punto a 1.5m al frente. Si perdés el equilibrio es información valiosa: ese sistema propioceptivo necesita más trabajo.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Para el equilibrio, empieza cerca de una pared para apoyo. Alejate gradualmente a medida que mejora la estabilidad.

1. Rodillas al pecho: 30 segundos.
2. Figura 4: 30 segundos por lado.
3. 90-90: 2 minutos con respiración 4-7-8.
4. Escaneo corporal: 1 minuto.

■ *El cierre no es opcional · los músculos se adaptan durante el descanso, no durante el ejercicio.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** La posición 90-90 con respiración 4-7-8 activa el sistema parasimpático, acelerando la recuperación y consolidando el aprendizaje motor.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si la posición 90-90 genera molestia, reemplazala por Figura 4 extendida o acostada con rodillas dobladas.

■ **Hábito del día:** Hoy hiciste la sesión mas completa hasta ahora. Anota que ejercicio antes imposible hoy fue posible — eso es neuroplasticidad motora visible.

DIA 14

Dos semanas. Ya no es motivación · es identidad - 20 minutos

■ 14 días de ejercicio consistente producen cambios estructurales en el cortex motor. Los patrones de movimiento aprendidos empiezan a almacenarse en memoria motora a largo plazo.

EJERCICIOS

01 Evaluación de 14 días

Responde en tu cuaderno antes de los ejercicios:

Nivel de dolor promedio esta semana vs. semana 1 (0-10): ____

Que ejercicio era imposible hace 14 días y hoy puedes hacer: ____

En que momento del día te sentis mejor: ____

Que habito ya cambiaste sin esfuerzo: ____

■ *La auto-evaluación activa la metacognición · la conciencia de tu propio proceso de aprendizaje. Esto acelera la consolidación de los cambios.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si el dolor no mejoro tanto como esperabas, revisa la calidad de ejecución, no la cantidad. Un ejercicio bien hecho 5 veces es mas efectivo que 15 mal ejecutados.

SI HAY DIFICULTAD

■ Si hubo días que no pudiste hacer ejercicio, no te penalices. Lo importante es volver al día siguiente.

1. Bird-Dog: 10 segundos con buena forma? Si/No.
2. Puente unilateral: 5 segundos sin que la cadera caiga?
3. Plancha en rodillas: 30 segundos con buena forma?
4. Equilibrio con ojos cerrados: cuantos segundos?
5. Comparalos con los resultados del Día 7.

■ *Los tests funcionales miden el aprendizaje motor, no solo la fuerza. La mejora en el control es el indicador mas preciso.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: El equilibrio con ojos cerrados es el test mas sensible de la propiocepción. Si mejorastes aunque sea 2-3 segundos, el sistema propioceptivo esta respondiendo.

SI HAY DIFICULTAD

■ Hace los tests sin presionarte. Son puntos de referencia para vos, no para nadie mas.

■ 14 días completados! Seguir en el 10% de personas que llegan a la mitad de un programa de ejercicio. La segunda mitad es donde ocurren los cambios mas grandes.

DIA 15

Fuerza avanzada

Core y miembros — nivel siguiente - 25 minutos

■ Semana 3: el sistema nervioso ya "aprendió" los patrones básicos. Ahora aumentamos la carga para desarrollar fuerza real — el ingrediente que convierte el alivio temporal en recuperación duradera.

EJERCICIOS

01 Plancha completa

1. Apoyáte en palmas y puntas de pie. Columna recta.
2. Activá el abdomen Y apretá los glúteos.
3. El cuerpo forma una línea recta de cabeza a talones.
4. Mantené 20-30 segundos. 3 series.



■ La activación del glúteo en la plancha reduce la presión lumbar en un 40%. Respirá durante la plancha — nunca contengas el aliento.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Apretar los glúteos en la plancha es lo que PROTEGE la espalda baja. Si sentís que la zona lumbar carga, probablemente los glúteos están relajados. Apretálos activamente.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si la espalda baja cae, volvé a la plancha de rodillas. No fuerces la versión completa hasta que el core sea más fuerte.

02 Sentadilla búlgara — Split Squat

1. Apoyá el pie trasero sobre una silla o banco.
2. La pierna delantera a distancia suficiente para que la rodilla no pase el pie.
3. Bajá el cuerpo en línea recta, rodilla trasera hacia el suelo.
4. 8 repeticiones por lado. 3 series.



■ Es el ejercicio unilateral con mayor activación del glúteo mayor y cuádriceps — ideal para corregir desequilibrios entre piernas.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si perdés el equilibrio, sujetáte de una pared. La rodilla trasera apunta hacia el suelo, no hacia atrás. Empezá con rangos pequeños hasta dominar la coordinación.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si hay dolor de rodilla en la pierna delantera, verificá que la rodilla no pase la punta del pie. Si persiste, hacé sentadilla asistida hasta fortalecer más el cuádriceps.

03 Hip Thrust — Puente en banco

1. Apoyá la parte superior de la espalda en un sofá o silla baja.
2. Pies en el suelo, separados al ancho de cadera.
3. Elevá las caderas formando una línea recta hombro-rodilla.
4. Apretá glúteos arriba. 3 segundos. Bajá. 15 repeticiones.



■ Activa el glúteo mayor un 60% más que el puente de suelo — es el ejercicio más efectivo para la fuerza glútea.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: La barbilla hacia el pecho durante el movimiento protege el cuello. Los pies separados al ancho de la cadera. Empujá desde los talones, no desde la punta del pie.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si no tenés banco o sofá adecuado, hacélo directamente en el suelo (puente básico con más control). El beneficio es menor pero igual de válido.

■ Hábito del día: Las escaleras son tu mejor aliado. Cada vez que subís escaleras, activá conscientemente el glúteo de la pierna que empuja — transforma un movimiento cotidiano en ejercicio terapéutico.

DIA 16

Cadena posterior completa

Dead Bug avanzado y variantes - 25 minutos

■ La cadena posterior (glúteos, isquiotibiales, extensores espinales) es el sistema de absorción de carga de la columna. Entrenarla en conjunto es lo que genera la estabilidad funcional real.

EJERCICIOS

01 Dead Bug avanzado con resistencia

1. Posición de Dead Bug estándar.
2. Exhalá completamente antes de cada repetición.
3. Extendé brazo y pierna opuestos hasta casi tocar el suelo.
4. La zona lumbar permanece COMPLETAMENTE plana. 10 por lado.



■ Versión avanzada que demanda mayor co-contracción del core en el rango completo de movimiento de los miembros.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Antes de cada repetición, exhalá completamente y "metéte el ombligo" — eso pre-tensa el transverso. La lumbar plana en el suelo es más importante que el rango completo de extensión.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si la espalda se despegas al extender completamente, detené la extensión a 45°. El beneficio viene del control, no del rango.

■ Hábito del día: Al final de cada jornada laboral, hacé 5 minutos de Cat-Cow + Rotación lumbar + Respiración diafragmática. Esa "descarga" nocturna previene la acumulación de tensión semana a semana.

DIA 17

El circuito del core

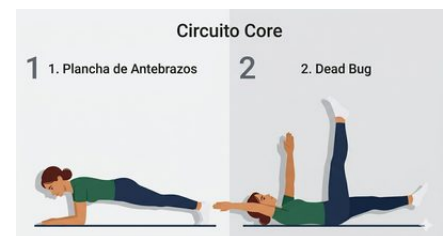
Resistencia sin pausa - 25 minutos

■ El circuito de core entrena la resistencia muscular — la capacidad de mantener la estabilidad durante actividades prolongadas. Es lo que protege la columna durante una jornada de trabajo, no solo en los 20 minutos de ejercicio.

EJERCICIOS

01 Circuito de core — Integración

1. Dead Bug: 10 repeticiones por lado.
2. Bird Dog: 10 repeticiones por lado.
3. Plancha: 20 segundos.
4. Puente de cadera: 15 repeticiones.
5. Repetí el circuito 3 veces. Descansá 30 segundos entre rondas.



■ *El circuito sin pausa aumenta la activación muscular acumulada y la eficiencia metabólica del entrenamiento de core.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si necesitás más descanso entre ejercicios, tomá 10-15 segundos extra. La clave es no perder la calidad de ejecución por cansancio. Un circuito bien hecho en 2 rondas > 3 rondas con mala forma.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si el circuito completo es demasiado al principio, hacé solo 2 de los 4 ejercicios. Agregá los demás cuando tu resistencia mejore.

■ Hábito del día: Mirá tu progreso — comparáte con el Día 8, no con nadie más. El circuito que hoy completás era imposible hace 10 días. Eso es neuroplasticidad visible.

DIA 18

Integración funcional

Circuito completo + test semana 3 - 22 minutos

■ La integración funcional conecta fuerza, movilidad y coordinación en los patrones de movimiento real. Bisagra, sentadilla, empuje, tirón — si tu cuerpo puede hacer estos bien, puede hacer cualquier tarea de la vida diaria.

EJERCICIOS

01 Circuito funcional — 2 rondas

1. Bisagra de cadera: 10 repeticiones.
2. Sentadilla asistida o goblet: 10 repeticiones.
3. Romanian Deadlift (RDL): 10 repeticiones.
4. Hip Thrust: 12 repeticiones.
5. Step-Up controlado: 8 por lado.
6. Plancha: 30 segundos.
7. 90 segundos de descanso entre rondas. 2 rondas totales.

■ *Los patrones funcionales (bisagra, sentadilla, empuje, tirón) son la base de todos los movimientos cotidianos. Entrenarlos en conjunto es mas eficiente que ejercicios aislados.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si algún ejercicio nuevo genera inseguridad, reducí el rango a la mitad y usá un apoyo. La seguridad en el movimiento se construye con repeticiones de calidad, no con esfuerzo máximo.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si el circuito completo es demasiado exigente, hacé solo los primeros 4 ejercicios en 2 rondas. Agregá los ultimos 2 la semana siguiente.

1. Sentadilla profunda sin peso: caderas bajo rodillas con talones en suelo?
2. RDL: la columna se mantiene neutral en todo el rango?
3. Plancha completa: cuantos segundos con buena forma?
4. Equilibrio con ojos cerrados: cuantos segundos?
5. Compara con el Día 14.

■ *El test de sentadilla profunda es el indicador mas completo de la movilidad de cadera, tobillo y columna — tres zonas clave para la salud lumbar.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si la sentadilla profunda todavia no llega a paralelo, no pasa nada. La movilidad de tobillo y cadera mejora con mas lentitud que la fuerza. El progreso es real aunque sea gradual.

SI HAY DIFICULTAD

■ Hacé los tests sin presionarte. Son información, no juicio.

■ Hábito del día: Bisagra, sentadilla, empuje, tirón, rotación, marcha. Si tu cuerpo puede hacer estos 6 patrones bien, puede hacer cualquier tarea de la vida diaria sin dolor.

DIA 19

Fuerza sostenida

Glúteo y core en máxima activación - 22 minutos

■ La semana 3 es la mas exigente del programa. El DOMS (dolor muscular de aparición tardía) puede ser mayor · eso es señal de adaptación muscular, no de lesión.

EJERCICIOS

01 Puente unilateral

1. Puente de cadera normal, levanta una pierna extendida.
2. La cadera no cae al lado de la pierna elevada — el core lateral trabaja.
3. Mantené 5 segundos arriba. 8 por lado.
4. 3 series.

■ *El puente unilateral activa el gluteo medio y el quadratus lumborum del lado de apoyo — los estabilizadores laterales mas importantes de la pelvis.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Si la cadera cae hacia el lado de la pierna levantada, es el gluteo medio del lado de apoyo el que esta fallando. Ese es exactamente el músculo que necesitas entrenar.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si el puente unilateral es demasiado difícil, hace el puente bilateral con tempo mas lento (3 seg subir, 5 seg sostener, 3 seg bajar).

02 Combinación fuerza + movilidad

1. Bisagra: 10 reps > Figura 4: 30 seg por lado.
2. Hip Thrust: 12 reps > Estiramiento de psoas: 30 seg por lado.
3. Sentadilla goblet: 10 reps > 90-90: 2 minutos.

■ *Fuerza y movilidad en la misma sesión: el sistema nervioso aprende a usarlas juntas · exactamente lo que necesitas en la vida real.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: El estiramiento después de cada ejercicio de fuerza es mas efectivo que al final de la sesión · el músculo caliente tiene mayor capacidad de elongación.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Esta es la semana mas exigente. Si algún día te sentis muy cargada, haces solo el calentamiento y los estiramientos. Eso también es entrenamiento inteligente.

■ Hábito del día: Descansá bien esta semana · el sueño de calidad es cuando los músculos se adaptan y el sistema nervioso consolida el aprendizaje motor. 7-8 horas no es lujo, es recuperación.

DIA 20

Flujo semana 3

Integración avanzada - 22 minutos

■ Hoy el objetivo no es sumar repeticiones sino observar: como se siente el cuerpo comparado con el Día 8? Los movimientos que antes requerían concentración ahora deben sentirse más naturales.

EJERCICIOS

01 Flujo completo Fase 2

1. Calentamiento: Respiración + Inclinação pélvica + Gato-Vaca (5 min).
2. Bloque core: Dead Bug + Bird Dog + Plancha (8 min).
3. Bloque fuerza: Sentadilla + Bisagra + Hip Thrust (8 min).
4. Cierre: Figura 4 + 90-90 + Escaneo corporal (4 min).

■ *El flujo completo de la Fase 2 integra movilidad, core y fuerza de cadena en una sola sesión continua · el patrón de entrenamiento mas eficiente para la columna.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Nota cuales movimientos ya se sienten naturales y cuales todavia requieren concentración. Los que requieren concentración son los que mas beneficio te dan · el sistema nervioso esta trabajando mas.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si la sesión completa es demasiado larga, corta el bloque de fuerza a 2 ejercicios. Mañana es la evaluación final · hoy el objetivo es llegar descansada.

■ Hábito del día: Mañana es la evaluación final de la Fase 2. Descansa bien · el sueño de calidad antes de un test mejora el rendimiento un 10-15%.

Evaluación Fase 2

- 25 minutos

■ 21 días. Movilidad + fuerza + control motor. El sistema nervioso tiene ahora patrones de movimiento que no tenía antes. Eso es un cambio estructural, no solo una mejora temporal.

EJERCICIOS

01 Evaluación final Fase 2

Respondé en tu cuaderno:

Dolor promedio esta semana vs. semana 1 (0-10): ____

Sentadilla profunda: caderas bajo rodillas con talones en suelo? Si/No

Plancha completa: cuantos segundos?

Equilibrio un pie con ojos cerrados: cuantos segundos?

Que ejercicio paso de imposible a posible?

■ *La evaluación final cierra el loop de aprendizaje de la Fase 2. Comparar con el Día 7 y el Día 14 da una curva de progreso que es evidencia concreta de neuroplasticidad.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: El progreso en estabilidad tarda mas en sentirse que en movilidad — pero es el que dura. Si en la plancha y el equilibrio mejoraste, la columna esta mas protegida que hace 21 días.

SI HAY DIFICULTAD

■ Lo que sigue: la Fase 3 integra todo en patrones de libertad real y diseña el protocolo que usas para siempre. Estas lista.

■ 21 días completados! La Fase 3 integra todo lo que construiste en la libertad real de movimiento. Una semana mas para cerrar el ciclo.

DIA 22

Moverse sin miedo

McKenzie + movilidad avanzada - 25 minutos

■ El miedo al movimiento (kinesiofobia) es el factor que más predice la cronicidad del dolor. La Fase 3 trabaja exactamente eso: moverse con confianza, explorar el rango completo, vivir sin restricciones.

EJERCICIOS

01 McKenzie Press-Up — Extensión lumbar activa

1. Acostáte boca abajo, palmas a la altura de los hombros.
2. Extendé los brazos elevando el torso, mientras la pelvis permanece apoyada.
3. Arqueá suavemente la espalda baja. Sin forzar el rango.
4. Sostené 2 segundos. Bajá lento. 10 repeticiones.



■ El Método McKenzie es el protocolo con más evidencia para dolor lumbar discogénico. La extensión "centraliza" el dolor — si el dolor deja de irradiar y se concentra en la lumbar, es señal positiva.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Buscá la "centralización": si el dolor se concentra en la zona lumbar y deja de irradiar hacia la pierna, es una señal MUY positiva. Si al contrario el dolor irradia más, detené y consultá a tu fisioterapeuta.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si hay aumento del dolor irradiado al intentarlo, detené este ejercicio. Para algunos perfiles (flexión), McKenzie no es el primer enfoque. Consultá.

1. Sentáte en silla o en suelo con piernas cruzadas.
2. Poné una mano detrás de la cabeza.
3. Rotá el codo hacia arriba, abriendo la espalda torácica.
4. 10 repeticiones por lado. Exhalá al rotar.



■ La columna torácica es la zona más rígida en el dolor crónico. Su liberación descarga tanto el cuello como la lumbar.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Exhalá al rotar — la caja torácica se libera más con el pulmón vacío. El movimiento debe venir de entre los omóplatos, no de la cintura.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si hay rigidez severa, hacélo acostada de lado (open book): girar el brazo de arriba hacia atrás. Más fácil y trabaja exactamente lo mismo.

■ Hábito del día: La libertad de movimiento se entrena, no se espera. Hoy comprometéte a hacer 2 minutos de movilidad torácica (rotaciones) antes de sentarte a trabajar — cada día, de por vida.

DIA 23

Resistencia real

Fuerza avanzada e integración - 25 minutos

■ La resistencia muscular — no la flexibilidad, no la fuerza máxima — es el factor más protector contra la recaída del dolor lumbar. Este día construye exactamente eso.

EJERCICIOS

01 Peso muerto unipodal con apoyo

1. De pie, una mano tocando la pared para equilibrio.
2. Con espalda recta, incliná el torso hacia adelante elevando la pierna trasera.
3. La pierna libre sube mientras el torso baja — forman una línea horizontal.
4. Vuelve. 8 repeticiones por lado.



■ *Entrena la cadena posterior en cadena abierta unilateral — el patrón más transferible a caminar, subir escaleras y levantarse del suelo.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Los ojos fijos en un punto a 1.5m al frente mejoran el equilibrio. La espalda neutral es más importante que el rango. Empezá sin peso — el propio peso corporal ya genera suficiente carga.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Empezá con la mano en la pared hasta que el equilibrio sea estable. Alejáte progresivamente de la pared en las semanas siguientes.

■ Hábito del día: El equilibrio en una pierna es el indicador de salud funcional más predictor de longevidad según estudios recientes. Practicálo en actividades cotidianas: cepillarte los dientes, esperar el ascensor, hablar por teléfono.

DIA 24

Mente y movimiento

Integración neuromotora - 25 minutos

■ La integración neuromotora conecta la fuerza construida con los patrones de movimiento real. El sistema nervioso necesita practicar los movimientos en múltiples planos y velocidades para generalizar el aprendizaje.

EJERCICIOS

01 Rotación de cadera 90-90

1. Sentáte en el suelo con ambas piernas dobladas a 90° (posición Z).
2. Una cadera en rotación interna, la otra en externa simultáneamente.
3. Mantené la posición 30 segundos. Respirá.
4. Cambiá de lado rotando las piernas. 3 series por lado.



■ *Moviliza la articulación coxofemoral en los rangos de rotación — los menos entrenados y los más limitados en personas con dolor lumbar y de cadera.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Esta posición es de movilidad, no de fuerza. La tensión en la cadera interna y/o glúteo es completamente normal. La gravedad sola es suficiente — no te apoyes con los brazos para forzar la posición.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si no podés llegar al suelo con ambas caderas, sentáte sobre un almohadón. Reducí la altura del apoyo progresivamente a medida que la movilidad mejora.

■ Hábito del día: Sentáte en el suelo más seguido. La posición de 90-90 y la posición con piernas cruzadas usan rangos de movilidad de cadera que la silla nunca usa. 10 minutos en el suelo = 10 minutos de movilización pasiva.

DIA 25

El cuerpo en el mundo

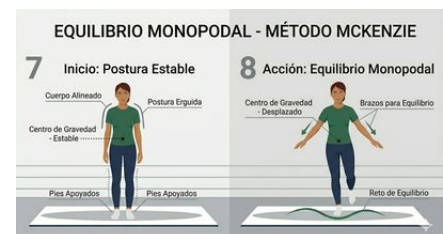
Propiocepción y equilibrio funcional - 25 minutos

■ El sistema propioceptivo es el GPS del movimiento — le dice al cerebro dónde está cada parte del cuerpo en el espacio. En el dolor crónico, este sistema se deteriora. Hoy lo re-entrenamos.

EJERCICIOS

01 Alcance de equilibrio en estrella — SEBT

1. De pie en una pierna. La otra libre para alcanzar.
2. Extendí la pierna libre hacia adelante, tocando el suelo.
3. Volvé al centro. Alcanzá hacia el lado. Hacia atrás. 3 direcciones.
4. 5 alcances por dirección. 2 por pierna.



■ *El Star Excursion Balance Test es el ejercicio de propiocepción con más evidencia para prevención de lesiones y rehabilitación funcional.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: El alcance en estrella entrena el sistema propioceptivo que previene caídas y lesiones. Si perdés el equilibrio, es información valiosa: ese patrón motor necesita más trabajo. Empezá con alcances cortos (20-30 cm).

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Empezá con solo 2 direcciones (adelante y al lado). Sujetáte de una pared si lo necesitás al principio. Agregá la dirección hacia atrás cuando tengas estabilidad en las dos primeras.

■ Hábito del día: Caminá descalza por casa. Las terminaciones nerviosas de la planta del pie son las que alimentan el sistema propioceptivo. 10 minutos descalza equivalen a un ejercicio de propiocepción pasivo.

DIA 26

Tu rutina para siempre

El protocolo de mantenimiento - 20 minutos

■ La ciencia muestra que 2 sesiones semanales de 20 minutos son suficientes para mantener los beneficios de 28 días de entrenamiento. Hoy diseñás esa rutina.

EJERCICIOS

01 Rutina de mantenimiento semanal

1. Respiración diafragmática: 5 minutos.
2. Movilidad (Cat-Cow + Rotación lumbar + Rotación torácica): 5 minutos.
3. Fuerza (Puente / Plancha / Bird Dog): 7 minutos.
4. Estiramiento (Piriforme + Cuadrado lumbar + Flexor de cadera): 3 minutos.



■ Esta secuencia de 20 minutos cubre los 3 sistemas clave: sistema nervioso autónomo (respiración), control motor (movilidad + fuerza) y tejido conectivo (estiramiento).

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

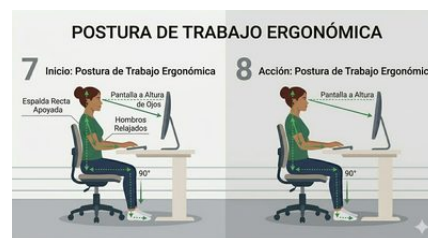
■ Tip: El protocolo de mantenimiento es lo que convierte 28 días de ejercicio en un cambio permanente. La ciencia muestra que la consistencia a largo plazo importa más que la intensidad de cada sesión.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: En semanas con poco tiempo, tu "sesión mínima" es: 5 respiraciones diafragmáticas + 10 puentes + 5 Cat-Cow. Son 4 minutos que mantienen el sistema activo.

02 Ergonomía en tu entorno

1. Pantalla a la altura de los ojos — no más baja.
2. Codos a 90° en el escritorio. Hombros relajados.
3. Espalda apoyada completamente en el respaldo.
4. Alarma cada 45 minutos para levantarte y moverte.



■ *Los ajustes ergonómicos tienen un impacto comparable a los ejercicios para el dolor cervical crónico según estudios de intervención en oficina.*

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ **Tip:** Estos 4 ajustes reducen la carga acumulada en la columna durante la jornada. La postura no tiene que ser perfecta todo el tiempo — la variación es lo que protege. El problema es la postura FIJA sostenida.

SI HAY DIFICULTAD

■ **Modificación:** Si no podés cambiar el escritorio: levánta el monitor con libros, programá la alarma de los 45 minutos en el teléfono, y hacé 3 respiraciones diafragmáticas cada vez que suene.

■ **Hábito definitivo:** Agendá 2 sesiones de 20 minutos por semana como cualquier otro compromiso. No es más tiempo — es diferente tiempo. Esas 40 minutos semanales son el precio de vivir sin dolor.

DÍA 27

El flujo final

Todo junto, una última vez - 25 minutos

■ Este es el momento en que todos los sistemas que entrenaste — respiración, movilidad, fuerza, equilibrio — se integran en un flujo de movimiento consciente. Notá la diferencia con el Día 1.

EJERCICIOS

01 Flujo final de integración

1. Respiración diafragmática 5 ciclos — llegás presente.
2. Cat-Cow 10 ciclos — columna se mueve libre.
3. Dead Bug 10 por lado — core activo.
4. Bird Dog 10 por lado — estabilidad integrada.
5. Sentadilla asistida 12 reps — potencia de cadena.
6. Puente de cadera 15 reps — glúteo activa.
7. Estiramiento: piriforme + flexor cadera + cuadrado lumbar.

■ *El flujo de integración consolida los patrones aprendidos en memoria motora a largo plazo.*



CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip: Hacélo con consciencia plena. Notá la diferencia de rango, de facilidad y de confianza respecto al Día 1. Esa diferencia tiene nombre: neuroplasticidad. Vos la creaste con constancia.

SI HAY DIFICULTAD

■ Modificación: Si algún ejercicio todavía genera incomodidad, incluyelo en su versión modificada (están en el día correspondiente). El flujo se adapta a vos, no al revés.

■ Hoy no es un hábito — es una celebración. Completar 27 días consecutivos de ejercicio consciente es un logro extraordinario. El dolor que tenías hace 27 días ya no es el mismo. Vos tampoco.

DÍA 28

La libertad

28 días — Evaluación y celebración - Tu tiempo

■ Veintiocho días. Un sistema nervioso diferente. Una columna más fuerte. Una vida con más movimiento y menos miedo.

EJERCICIOS

01 Test y evaluación final

1. Dolor promedio esta semana (0-10): ____
2. Rotación de cuello — ¿llegás al hombro? ____
3. Chin tuck — ¿10 reps sin compensar? ____
4. Puente de cadera — ¿15 reps fluidas? ____
5. Compará con el Día 1. Anotá 3 cambios que notás.



■ La evaluación final cierra el loop de aprendizaje. La diferencia entre el Día 1 y el Día 28 es evidencia medible de neuroplasticidad.

CONSEJO DEL FISIOTERAPEUTA

■ Tip de cierre: Si todavía tenés algo de dolor, es completamente normal. El proceso de desensibilización central toma 3-6 meses. Lo que cambió es tu capacidad de manejar el movimiento — y eso es el fundamento real de la recuperación.

SI HAY DIFICULTAD

■ Lo que sigue: 2 sesiones semanales del protocolo de mantenimiento (Día 26). Eso es todo lo que necesitás para mantener y seguir mejorando lo que construiste.

■ Felicitaciones. Completaste un programa basado en evidencia científica que la mayoría de las personas con dolor crónico nunca se da la oportunidad de terminar. Ese coraje, repetido 28 veces, es lo que cambia vidas.